

<血圧>

低血圧

透析中の血圧低下		
原因	対応	その他
DW がきつい	DW を上げる	家庭血圧・CTR・HANP・MLT・BV等を確認し、医師に報告
除水量が多い	除水量を減らす	除水速度はDW×15（ml/hr）以下を目標
低アルブミン血症	積層型への変更	目標値：3.5g/dl 以上 2.5g/dl 以下で低アルブミン
	アルブミン点滴	積層型ダイアライザーはアルブミンが抜けにくいメリット 低栄養ではないか患者に食生活の聞き取りを行う
貧血	貧血改善薬投与	基準値：Hb10～12g/dl
降圧薬が多い	降圧剤の確認	どのタイミングで降圧薬を飲んでいるかを確認 例：透析開始時の血圧が低い→前日の夕の降圧剤の量はどうか？ 透析後半の血圧が低い→当日の朝の降圧剤の量はどうか？

透析中の血圧低下時の症状

あくび・冷や汗・吐き気・嘔吐・腹痛・便意・シャント肢の痛み・声がれ 等

透析中の血圧低下時の対応（みたきマニュアルより一部改変）

※気分不快時・意識消失時にはまず補液！！

①血圧再検（マンシェットが緩い場合は巻き直す）

②除水停止

③液温を下げ血流量を 150ml/min におとす

④下肢挙上

⑤昇圧剤の検討・投与

透析開始直後（30 分以内）の急激な血圧低下		
原因	対応	その他
ダイアライザーの不適合	ダイアライザー変更	ダイアライザーの材質や添加物と血液が接触しアレルギー反応起こして血圧低下
抗凝固剤の不適合	抗凝固剤の変更	ヘパリン使用時は HIT、ナファモスタット使用時はアナフィラキシーショックによる血圧低下
酢酸不耐症	酢酸フリーの透析液を使用	酢酸が血中に入ることにより血圧低下 みたきの透析液は酢酸入り→酢酸が入っていない透析液を取り寄せる

※HIT…ヘパリン起因性血小板減少症

高血圧

高血圧		
原因	対応	その他
DW がゆるい	DWを下げる	浮腫・家庭血圧・CTR・HANP・MLT・BV等を確認し、医師に報告
透析間の増加量が多い	塩分・水分の指導	目標：食塩→6g/day 未満（体格によって多少前後） 水分→できるだけ少なく 水分制限よりも食塩制限の方が重要 人間の体は8gの食塩を摂取すると1ℓの水分を摂取してしまう 一日水分摂取量の目安；DW(kg)×15(ml)+尿量(ml)
レニン・アンジオテンシン系の亢進	降圧剤の検討	レニン・アンジオテンシン系（RA系）とは？ →腎臓への血流が減ると血圧が下がったかも？と体が反応 血圧をあげるホルモンのレニンが産生されて血圧が上昇する 健常人であれば血圧低下に伴いRA系が亢進
動脈の石灰化	リンが高値にならないよう指導	透析患者はリンが腎から排泄できず体にたまりやすい →血中のリンとカルシウムが結合し血管内に沈着し石灰化が進む 基準値：リン 3.5～6.0mg/dl

※透析中の血圧上昇の原因

RA系が原因の可能性が高い

除水で体液量減少→腎臓への血流量が減る→R A系が亢進し血圧上昇

内容に関する質問や意見等はME伊藤までお願いします。